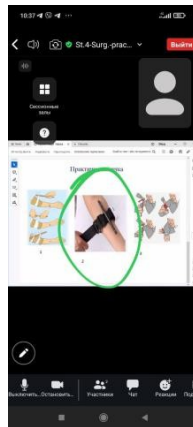
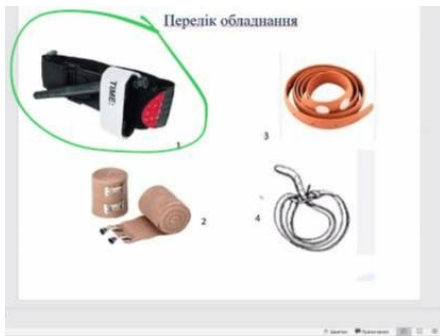


Накладання турнікету

Сценарій. У приймальному відділенні знаходиться постраждалий з ножовим пораненням нижньої третини лівого стегна та артеріальною кровотечею із рани, що триває. Потрібно накласти турнікет САТ.

перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Турнікет САТ	1 шт.



№ п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості та дихання.	Сказати
2	Встановити контакту з пацієнтом. Привітатись, представитися, позначити свою роль. Попросити пацієнта представитися. Визначити особливості анамнезу (механізм травми, алергічні реакції на ліки).	
3	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції (пояснити хід та мету процедури)	Сказати
4	Обробити руки та одягнути маску та медичні рукавички.	Виконати
5	Оглянути місце травми для визначення характеру ушкодження	Виконати Сказати.
6	Підготувати турнікет САТ до накладення, розгорнувши його	Виконати,

7	Накласти турнікет у верхній частині стегна, після чого просмикніть ремінь в скобу, затягнути його до упору і зафіксувати вільну частину ремінця, використовуючи	Виконати
---	--	----------

	застібку	
8	Провести обертання стрижня-фіксатора до припинення кровотечі.	Виконати Сказати
9	Зафіксувати стрижень-фіксатор в спеціальній скобі.	Виконати
Застебнути скоби липучкою і записати час накладення турнікету	Виконати	
10	Уточнити у пацієнта його самопочуття.	Сказати
11	Завершення процедури	Сказати

Діагностика

3.1. Оцінка характеру рани

Сказати: «Оцінюю рану: локалізована на внутрішній поверхні нижньої третини лівого

стегна, розміри 9×2 см, краї рівні, глибока. Така рана характерна для колоторізаного поранення з можливим ураженням магістральної артерії (a. Femoralis superficialis).»

3.2. Оцінка характеру кровотечі

Сказати: «Кров яскраво-червоного кольору, витікає пульсуюче — типово для артеріальної кровотечі. Кровотеча масивна, неконтрольована місцевими методами

до накладання турнікету.»

4. Визначення тактики ведення та лікування

4.1. Визначення максимальної тривалості знаходження турнікету САТ та необхідності оперативного лікування (ПХО)

Сказати: «Турнікет САТ накладено правильно, кровотеча зупинена. Максимальна допустима тривалість знаходження турнікету — до 1,5–2 годин. Необхідне термінове направлення пацієнта до операційної для проведення первинної хірургічної обробки рани, ревізії судин, зупинки кровотечі та можливого судинного шва або лікування судини.»

4.2. Призначення медикаментозних засобів

Сказати: «Призначаю:

– інфузійну терапію (кристалоїди, колоїди) для стабілізації гемодинаміки,

- гемостатичні препарати (етамзилат, транексамова кислота),
- антибактеріальну терапію для профілактики інфекцій у рані,
- протиправцеву сироватку та/або анатоксин (залежно від імунного статусу),
- знеболювальне (опіоїди за показаннями),
- моніторинг артеріального тиску, пульсу, свідомості.»

Завершення дій

Сказати: «Стан пацієнта тяжкий, показане екстрене оперативне втручання.

Підготовка до ПХО з попередньою стабілізацією гемодинаміки. Турнікет залишаю на кінцівці з фіксацією часу накладення на пов'язці. Маніпуляцію завершено.»